

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ÍNDICE DE KATZ DE INDEPENDENCIA EN ABVD

Eje IV: Funcionamiento y Autonomía • Modelo Jerárquico Ontogenético de Independencia en Cuidados Básicos

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Índice de Katz de Independencia en las Actividades de la Vida Diaria.
Nombre Original	Index of Independence in Activities of Daily Living (Index of ADL; Katz et al., 1963).
Autores Originales	Sidney Katz, M.D., Amasa B. Ford, M.D., Roland W. Moskowitz, Beverly A. Jackson y M. W. Jaffe.
Adaptación Hispana	Álvarez Solar et al. (1992); SEGG (Sociedad Española de Geriátría y Gerontología); España.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Autonomía. Independencia física básica en orden ontogenético.
Tipo de Instrumento	Heteroinforme de observación clínica / entrevista estructurada de 6 funciones biológicas.
Población y Rango	Adultos mayores, pacientes en rehabilitación geriátrica, crónicos e institucionalizados.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos de juicio profesional tras entrevista al paciente o cuidador.
Régimen de Licencia	Dominio público internacional / Acceso abierto sin restricciones comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL ORDEN JERÁRQUICO BIOLÓGICO DE KATZ

El **Índice de Katz** (1963, JAMA) fue diseñado para evaluar de manera estructurada el deterioro y la recuperación funcional en enfermos crónicos. Su descubrimiento más trascendente fue la constatación de que la pérdida y recuperación de las funciones de autocuidado no ocurre al azar, sino siguiendo un **orden jerárquico ontogenético acumulativo** (escala de Guttman):

- Involución Inversa al Desarrollo Infantil:** Las funciones que se aprenden más tarde en la infancia (como el baño y el vestido) son las primeras en perderse ante el deterioro neurológico o el envejecimiento biológico.
- Resistencia del Núcleo Vital Primario:** Las funciones más elementales y arcaicas (alimentación y continencia de esfínteres) son las más resistentes al declive, perdiéndose únicamente en estadios terminales de demencia o daño cerebral grave.
- Recuperación Homóloga:** Cuando un paciente se rehabilita tras un ictus, recupera las funciones en orden inverso a su pérdida: primero la alimentación, después el control esfinteriano y transferencias, y finalmente el vestido y baño.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (6 FUNCIONES BÁSICAS)

Función Básica	Puntuación	Criterios Operativos de Independencia según Katz
1. Baño / Ducha	0 o 1 pto	1 = Se baña enteramente solo o necesita ayuda solo para lavarse una zona (espalda); 0 = Dependiente.
2. Vestido	0 o 1 pto	1 = Coge la ropa de armarios, se viste y abotona solo (salvo atarse los cordones); 0 = Dependiente.
3. Uso del Retrete	0 o 1 pto	1 = Va al baño, entra, sale, se limpia y se arregla la ropa por sí mismo; 0 = Precisa ayuda.
4. Transferencias / Movilidad	0 o 1 pto	1 = Se levanta y acuesta en la cama solo, y se sienta/levanta de la silla sin ayuda; 0 = Dependiente.
5. Continencia de Esfínteres	0 o 1 pto	1 = Control completo de la micción y defecación (sin accidentes); 0 = Incontinencia parcial o total.
6. Alimentación / Comer	0 o 1 pto	1 = Lleva el alimento del plato a la boca por sí solo (se permite que le corten la carne); 0 = Precisa ayuda.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Estudios geriátricos españoles (Álvarez Solar et al., 1992; SEGG) ratifican la precisión del Índice de Katz:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Confiabilidad Interobservador	Kappa = 0.86 – 0.95	Excelente concordancia entre evaluadores médicos, enfermeros y terapeutas.
Escalabilidad de Guttman	Coef. Reproducibilidad > 0.92	Confirma la jerarquía biológica acumulativa de las funciones de autocuidado.
Consistencia Interna	Alfa α = 0.84 – 0.90	Elevada homogeneidad en la cuantificación de la dependencia biológica elemental.
Validez Predictiva (Mortalidad)	Riesgo Relativo = 2.8	La pérdida de continencia o alimentación predice mortalidad hospitalaria a un año.
Validez de Criterio	$r = 0.88$ (Barthel)	Correlación casi perfecta con las dimensiones de autocuidado del Índice de Barthel.

5. REGLAS DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA (GRADOS A A G)

- **Puntuación Dicotómica por Función:** Cada función se califica como **Independiente (1 punto)** o **Dependiente (0 puntos)**. Si el paciente rechaza realizar una función o requiere supervisión por seguridad, se califica como dependiente.
- **Puntuación Numérica Total:** Suma directa de las funciones independientes (**0 a 6 puntos**).
- **Clasificación Tipológica Jerárquica de Katz (Grados A a G):**
 - **Grado A:** Independiente en todas las 6 funciones (6 puntos).
 - **Grado B:** Independiente en todas menos en una cualquiera (5 puntos).
 - **Grado C:** Independiente en todas menos en baño y otra más (4 puntos).
 - **Grado D:** Independiente en todas menos en baño, vestido y otra más (3 puntos).
 - **Grado E:** Independiente en todas menos en baño, vestido, retrete y otra más (2 puntos).
 - **Grado F:** Independiente en todas menos en baño, vestido, retrete, transferencias y otra más (1 punto).
 - **Grado G:** Dependiente en todas las 6 funciones (0 puntos).
- **Otros:** Patrones no jerárquicos o atípicos (ej. incontinente pero capaz de bañarse solo).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN GERIÁTRICA

Estratificación	Puntuación	Grado Katz	Nivel de Dependencia y Necesidad de Cuidados
Independiente	6 pts	Grado A	Autonomía biológica plena; no precisa cuidadores formales para autocuidado.
Dependencia Leve	4 a 5 pts	Grados B o C	Pérdida de baño o vestido; precisa asistencia de apoyo 1 o 2 horas diarias.
Dependencia Moderada	2 a 3 pts	Grados D o E	Pérdida de uso de retrete y transferencias; cuidador necesario mañana y noche.
Dependencia Severa	1 pto	Grado F	Conservación exclusiva de alimentación; dependencia casi integral.
Dependencia Total	0 pts	Grado G	Dependencia biológica absoluta; encamamiento y asistencia 24 horas.

SIGNIFICACIÓN PRONÓSTICA DEL GRADO G (KATZ = 0 PUNTOS):

La caída al Grado G (dependencia total en las 6 funciones incluyendo alimentación) constituye un marcador clínico de estadio terminal en neurogeriatría (demencias avanzadas FAST 7), indicando necesidad de cuidados paliativos y prevención de broncoaspiración.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO GERIÁTRICO DE PRESERVACIÓN FUNCIONAL Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA

PROTOCOLO SECUENCIAL DE CUIDADOS SEGÚN EL ÍNDICE DE KATZ:

- **Paso 1 (Determinación de la Pérdida Funcional Activa):** Localizar el eslabón de la jerarquía que ha fallado.
- **Paso 2 (Estrategia ante Caída en Baño y Vestido [Grados B y C]):** Prescribir productos de apoyo: esponjas de mango largo, barras asideras en bañera y calzadores de mango extendido; no sustituir al paciente si conserva la iniciativa.
- **Paso 3 (Estrategia ante Fallo en Retrete y Transferencias [Grados D y E]):** Adaptar la altura del inodoro con alzas, programar micciones regladas cada 3 horas para evitar incontinencia y entrenar transferencias con andador.
- **Paso 4 (Protección de la Alimentación [Grados F y G]):** Si se pierde la autonomía para comer, pautar texturas modificadas (dieta triturada / espesantes) y postura en ángulo de 90 grados para prevenir neumonías aspirativas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: SEGUIMIENTO EN HOSPITALIZACIÓN DE MEDIA ESTANCIA

Identificación: Mujer de 83 años, ingresada en unidad de convalecencia tras intervención quirúrgica de fractura subtrocanterea de fémur izquierdo tras caída accidental en domicilio, con deterioro funcional grave secundario.

Evaluación Basal Katz (Día 3 postoperatorio):

- **Puntuación Total = 1 / 6 puntos (Grado F de Katz - Dependencia Severa).**
- *Baño = 0; Vestido = 0; Uso del Retrete = 0; Transferencias = 0* (Encamada, dolor agudo al movimiento); *Continencia = 0* (Portadora de sonda vesical temporal); *Alimentación = 1* (Come sola la bandeja del hospital).

Plan de Rehabilitación Funcional Geriátrica: Retirada precoz de sonda vesical, reeducación de suelo pélvico, fisioterapia motriz diaria para transferencias cama-sillón y entrenamiento en vestido con ropa holgada por terapia ocupacional.

Reevaluación al Alta (Semana 4): La puntuación ascendió a **4 / 6 puntos (Grado C de Katz - Dependencia Leve):**

- Recuperó transferencias (1), uso del retrete (1) y continencia completa (1), permaneciendo dependiente únicamente para el baño completo y ponerse los zapatos. Regresó a su casa con asistencia puntual de su hija.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PÉRDIDA ATÍPICA NO JERÁRQUICA:

Un paciente que pierde la alimentación conservando el baño o el vestido presenta un patrón no biológico; descartar depresión psicótica con rechazo de ingesta o dolor orofaríngeo grave.

EFFECTO TECHO EN ATENCIÓN PRIMARIA:

En ancianos que viven en comunidad sin discapacidad física motriz grave, el Katz arroja invariablemente 6/6 puntos; utilizar la Escala de Lawton para detectar pérdidas instrumentales sutiles.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A., & Jaffe, M. W. (1963). Studies of illness in the aged: The Index of ADL, a standardized measure of biological and psychosocial function. *JAMA*, 185(12), 914-919.
2. Álvarez Solar, M., et al. (1992). Capacidad funcional del anciano: Valoración mediante el índice de Katz. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 27(1), 11-15.
3. Brorsson, B., & Asberg, K. H. (1984). Katz Index of Independence in ADL: Reliability and validity in short-term care. *Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine*, 16(3), 125-132.
4. Spector, W. D., et al. (1987). The hierarchical relationship between activities of daily living and instrumental activities of daily living. *Journal of Chronic Diseases*, 40(6), 481-489.